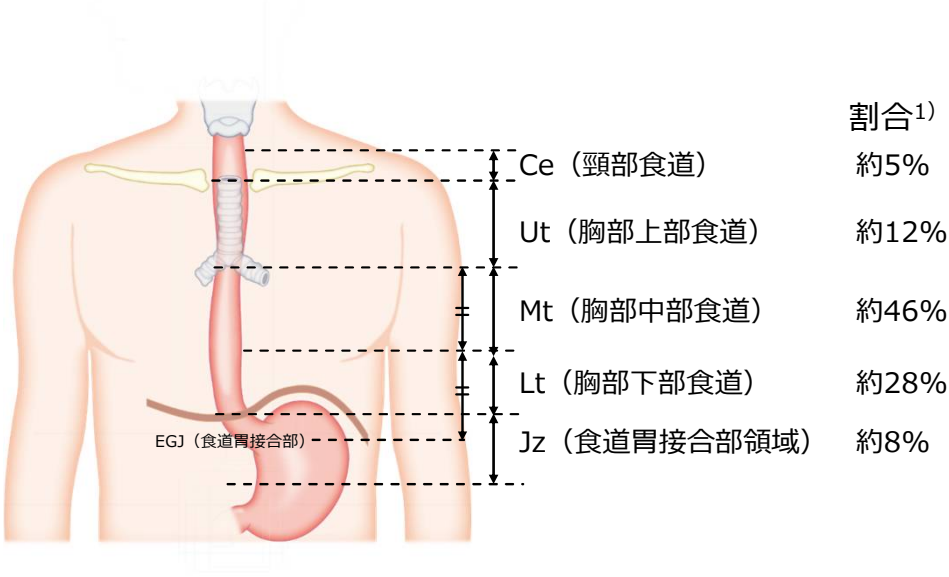


食道癌の占居部位・割合（日本人）

● 日本における食道癌の現況¹⁾

性別	男女比 約5：1
年齢	60～70歳代が全体の年齢層の約74%
占居部位	胸部中部食道：約46% 胸部下部食道：約28% 胸部上部食道：約12% 食道胃接合部領域：約8% 頸部食道：約5%
組織型	扁平上皮癌：約87% 腺癌：約5%

● 食道癌の占居部位^{2,3)}



対象 2015年に国内355施設へ受診した患者9,368例

方法 日本食道学会による食道癌全国登録のデータ（Webベースのデータ収集システムである National Clinical Database）を解析した。

1) Watanabe M et al. *Esophagus* 2023; 20: 1-28

2) 桜本信一, 他著 持田智 他編. 新体系 看護学全書 成人看護学⑤ 消化器 第5版, メヂカルフレンド社, p142, 2018

3) 日本食道学会 編. 食道癌取り扱い規約 第12版, 金原出版, p7, 2022より作成

食道癌のリスク因子

危険因子	扁平上皮癌	腺癌
喫煙	+++	++
飲酒	+++	—
バレット食道	—	+++++
逆流性食道炎	—	+++
肥満	—	++
貧困	++	—
アカラシア	+++	—
食道損傷	+++++	—
頭頸部癌歴	+++++	—
乳癌放射線治療歴	+++	+++
頻回な熱い飲料の飲用(マテ茶)	+	—

予防因子： β カロチン、ビタミンC、野菜・果物など

Enzinger PC, et al. NEJM 349:2241, 2003

食道がん薬物療法で使う薬剤

1. プラチナ系

- シスプラチン
- ネダプラチン
- オキサリプラチン（FOLFOX療法時のみ）

2. フッ化ピリミジン系

- フルオロウラシル
- S-1

3. タキサン系

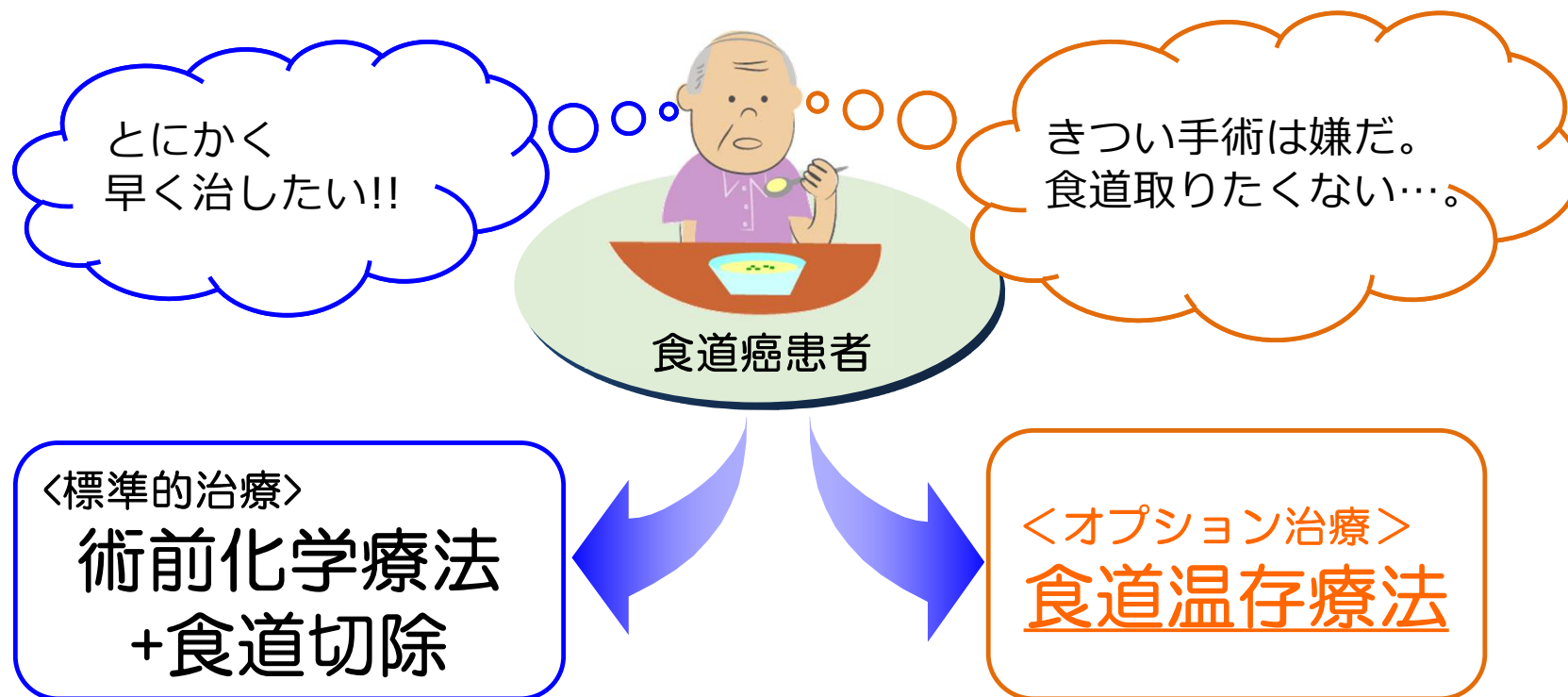
- パクリタキセル
- ドセタキセル

4. 免疫チェックポイント阻害薬

- ペムブロリズマブ（抗PD-1抗体）
- ニボルマブ（抗PD-1抗体）
- チスレリズマブ（抗PD-1抗体）
- イピリムマブ（抗CTLA-4抗体、ニボルマブと併用時のみ）



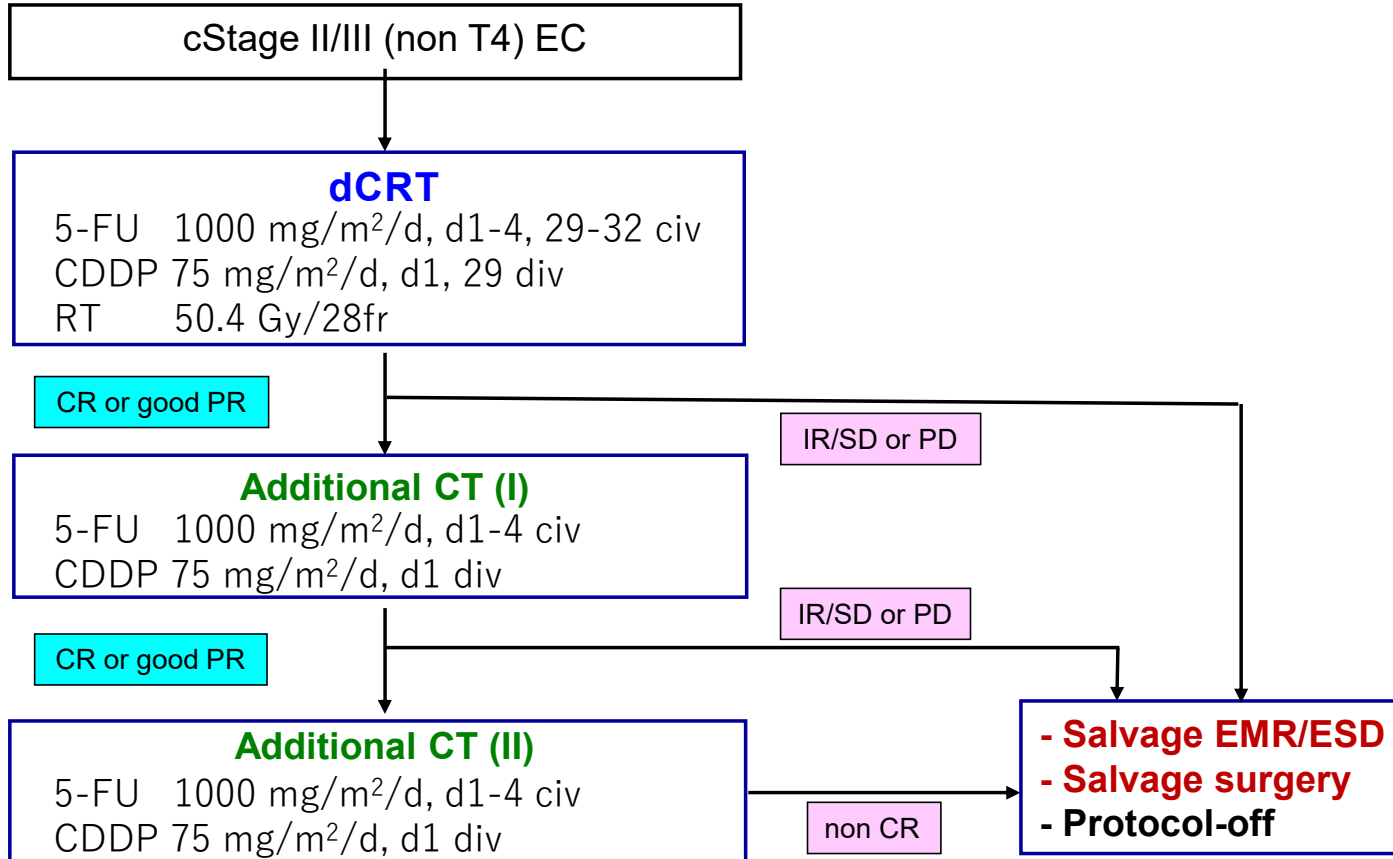
切除可能食道がん（Stage II-III）



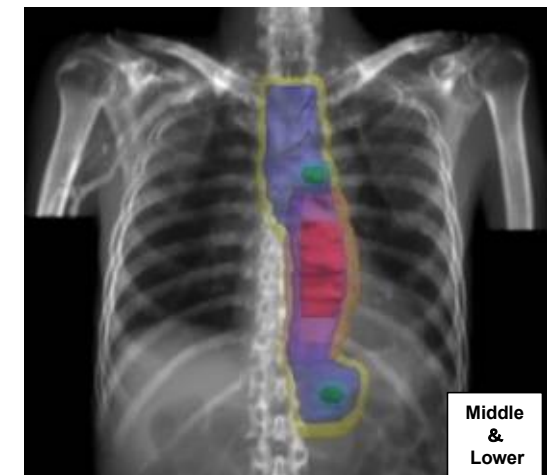
右開胸、食道全摘、リンパ節郭清
主に胃管再建
周術期死亡 5%
切除可能食道癌の5生率は34~50%

Stage I-III
化学放射線療法
Stage I
内視鏡治療 + 放射線治療

JCOG0909



Schema of RT port up to 41.4 Gy





cStage IVBに対する化学療法レジメン

一次化学療法

二次化学療法

三次化学療法

CQ15

5-FU シスプラチン ペムブロリズマブ

5-FU シスプラチン ニボルマブ

イピリムマブ ニボルマブ

■タキサン系薬剤未使用例

パクリタキセル

5-FU シスプラチン

一次治療：フッ化ピリミジン,
プラチナ併用療法不応

■抗PD-1抗体薬未使用例

ニボルマブ

CPS $\geq$ 10かつ扁平上皮癌, またはMSI-H

ペムブロリズマブ

一次治療：フッ化ピリミジン,
プラチナ併用療法不応
二次治療：抗PD-1抗体療法

■タキサン系薬剤未使用例

パクリタキセル